

DELIRIUM. SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO

Javier Trigo López, Enrique Martínez Pías, David García Azorín.

INTRODUCCIÓN

El concepto de Delirium o síndrome confusional se define en la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) como el cuadro de inicio agudo y curso fluctuante consistente en alteración de la atención, del nivel de conciencia y síntomas de la esfera cognitiva como alteraciones de memoria, orientación, o percepción; producido como consecuencia directa de otro proceso médico o el efecto de una sustancia y que no se explique por alteraciones neurocognitivas previas ni suceda en el contexto de un nivel de conciencia gravemente reducido.

Su prevalencia estimada es del 7-24 % entre los pacientes que acuden a urgencias, siendo especialmente frecuente en la población anciana. Dado que las causas que pueden originarlo son muy variadas y de diferente gravedad, es crucial su adecuado diagnóstico y pronto tratamiento ya que la morbilidad llega a duplicarse en aquellos pacientes con diagnóstico tardío y/o erróneo.

Su clínica no siempre es fácilmente reconocible; su curso fluctuante, si bien es un dato típico, puede confundir en el diagnóstico; por otra parte, algunos de los síntomas deficitarios pueden ser interpretados como típicos de la edad avanzada, siendo fundamental el testimonio de un familiar. La sintomatología típica engloba desorientación en cualquiera de las tres esferas, especialmente la temporal, con inversión del ritmo sueño-vigilia; alteración del nivel de alerta, con marcada inatención y la alteración de conducta, la cual puede oscilar desde estados letárgico-apáticos hasta la inquietud psicomotriz y agresividad. Es característico que los pacientes presenten alteración del lenguaje, pero exclusivamente de su contenido, relatando eventos disparatados o imaginarios, pero sin alteración gramatical del mismo, ya que la presencia de afasia como tal, debe obligar a excluir patología focal neurológica como una encefalitis herpética. Otro de los síntomas habituales es la alteración de la percepción en forma de ilusiones o alucinaciones.

En su evaluación es crucial excluir la presencia de síntomas o signos neurológicos ya que el síndrome confusional es generalmente un proceso de encefalopatía difusa atribuible a una causa, de modo que la presencia de síntomas o signos focales obliga a excluir patología estructural del sistema nervioso central.

DIAGNÓSTICO

Dada la gran variedad clínica de su presentación, su detección en urgencias supone un reto diagnóstico para el facultativo y debe existir un alto índice de sospecha.

En primer lugar, es fundamental diferenciar el síndrome confusional de los síntomas cognitivos propios de un proceso de neurodegenerativo primario (TABLA 1), para ello es crucial interrogar a familiares y testigos para indagar sobre el inicio de los síntomas y el curso de estos. La mayor dificultad reside en que muchos pacientes con un proceso de alteración cognitiva son especialmente vulnerables a la aparición de síntomas cognitivos y estos pueden ser el primer marcador del proceso subyacente, el cual deberá ser estudiado una vez resuelto y tratado el cuadro confusional.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre síndrome confusional, demencia y psicosis.

	Síndrome confusional agudo	Demencia	Psicosis
Inicio	Agudo (horas)	Gradual (meses)	Agudo/ subagudo
Curso	Fluctuante	Progresivo	Estable
Atención	Alterada	Conservada en fases iniciales	Puede alterarse
Duración	Transitorio	Persistente	Variable
Nivel de conciencia	Fluctuante / disminuida	Conservado en fases iniciales	Normal
Percepción/ alucinaciones.	Alucinaciones frecuentes, sobre todo visuales	Alucinaciones raras	Alucinaciones frecuentes, sobre todo auditivas.
Lenguaje	Incoherencia	Afasia frecuente	Rápido, normal o lento
Actividad psicomotriz	Retardada, agitada o mixta	Normal	normal
Ciclo vigilia-sueño	Alterado	Normal	Alterado
Enfermedad orgánica	Si	No	No

El diagnóstico sindrómico y etiológico del delirium se representan en el ALGORITMO 1.

Tras la determinación de los parámetros vitales y la exploración sistémica, se pasará a la valoración neurocognitiva. Para realizar un diagnóstico sindrómico, la evaluación del estado mental debe incluir la evaluación del nivel de conciencia, atención, orientación y una breve evaluación de las funciones cognitivas superiores.

El nivel de conciencia puede evaluarse describiendo cuál es el estímulo necesario para que el paciente reaccione, si es estimulación verbal a tono normal, a tono intenso, estímulo mecánico suave, vigoroso o estímulo doloroso, de manera que sucesivos exploradores puedan monitorizar el nivel de conciencia de manera sencilla y reproducible.

El nivel de atención se hace con pruebas sencillas, tales como enumerar los meses del año en orden inverso o los días de la semana al revés, evaluando si existe omisión de elementos, cambio de orden o aumento de latencia. Otras pruebas de mayor complejidad son el Span de Dígitos, analizando cuántos dígitos es capaz el paciente de repetir tras decir estos el examinador. Seguidamente debe evaluarse la orientación en las tres esferas.

Es fundamental realizar una apropiada exploración neurológica, en la que se evaluará el lenguaje, tanto la expresión, comprensión, nominación como repetición. Es frecuente que exista una alteración del contenido del lenguaje, siendo habitualmente disparatado, pero la presencia de alteración en la forma del lenguaje obliga a excluir un proceso cerebral focal, siendo los más frecuentes los de causa vascular, comicial e infeccioso. Se incluirán el resto de sistemas neurológicos y no se olvidará valorar la presencia de rigidez nuchal, interpretándola con cautela dado que en la población anciana puede ser de difícil interpretación.

En cuanto al diagnóstico etiológico es fundamental realizar una adecuada anamnesis, preferiblemente en presencia de familiares o acompañantes. Es importante recabar información sobre el estado cognitivo previo, uso de medicación o cambios de la misma. A la hora de evaluar síntomas, dado que la causa más frecuente de síndrome confusional es la infecciosa, deberá interrogarse sobre síntomas sugestivos de infección, pese a que en muchos casos no sean prominentes incluso en presencia de proceso infeccioso. No debe olvidarse interrogar sobre traumatismos craneoencefálicos u otros procesos médicos recientes, tratando de dirigir el estudio en función de la sospecha.

Tras una correcta anamnesis y exploración física deberán solicitarse las pruebas complementarias en función de la sospecha etiológica. En ausencia de sospecha específica, se recomienda realizar: Ver Algoritmo.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, GOT, GPT, PCR, Bilirrubina total y fraccionada, LDH, amilasa, PCR, VSG.
- Coagulación básica.
- Gasometría venosa o arterial según clínica.
- Sedimento y sistemático de orina con tóxicos en orina: descartar foco febril en ancianos y en jóvenes casos valorar determinación de tóxicos en orina (dejaremos constancia en historia clínica autorización verbal o escrita si existe acompañante o el paciente pueda dárnosla).
- Mujeres jóvenes test de embarazo.
- Hemocultivos, urocultivo.
- TAC Craneal. Descartar masas, lesiones cerebrales, accidente cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea, etc.
- Punción lumbar: descartar meningitis, encefalitis, hemorragia subaracnoidea.
- Rx tórax AP-Lat. Descartar signos de ICC, TEP, condensaciones, etc.
- ECG: Descartar taquiarritmias, IAM, alteraciones iónicas, TEP.
- Ya ingresado valorar: hormonas tiroideas (TSH, T4L), autoinmunidad (ANA, ANCA, complemento), cortisol, estudios serológicos (VIH, sífilis (RPR), virus, hongos), porfirinas, vitaminas B12, ácido fólico, tiamina, niveles de fármacos, etc. RMN cerebral.

TRATAMIENTO

El tratamiento del síndrome confusional consiste fundamentalmente en la corrección de la causa médica subyacente, de ahí que su adecuado y pronto diagnóstico sea crucial.

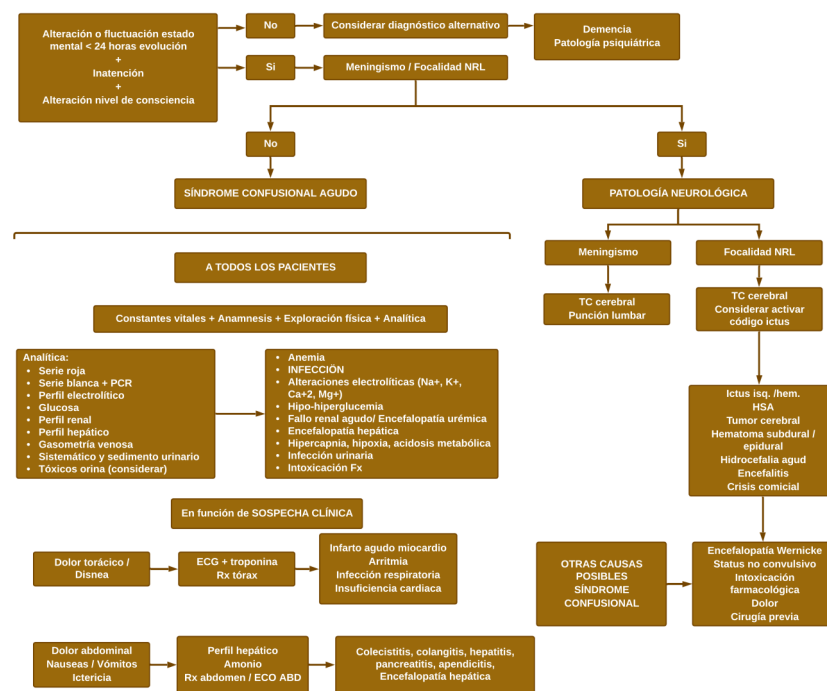
Dentro de las medidas a considerar, es conveniente mantener al paciente un ambiente tranquilo, sin excesivo ruido, y preferiblemente acompañado de algún familiar, siendo necesario en ocasiones el uso de un tratamiento farmacológico coadyuvante (TABLA 2).

Las medidas físicas de contención deben reservarse para pacientes agresivos o gravemente agitados con el objetivo de facilitar la seguridad del paciente y personal sanitario. Su aplicación debe ser reflejada en la historia clínica, justificándose su empleo.

Fármaco	Dosis	Efectos secundarios
Haloperidol	2.5 mg-10 mg oral, im, iv	• QT prolongado • Síntomas extrapiramidales (se trata con biperideno) • Hipotensión ortostática
Olanzapina (Zyprexa)	5-10 mg im.	• QT prolongado • Síntomas extrapiramidales • Hipotensión ortostática
Quetiapina	25-100 mg iv	• QT prolongado • Somnolencia • Síntomas extrapiramidales

Tabla 2. Neurolépticos útiles como tratamiento sintomático en el síndrome confusional agudo.

Algoritmo de delirium o síndrome confusional



BIBLIOGRAFÍA

- Hidetaka Tamune, Daisuke Yasugi, How can we identify patients with delirium in the emergency department? The American Journal of Emergency Medicine 2017
- Altered Mental Status and Delirium. Scott T. Wilber, Jason E. Ondrejka. Emergency Medicine Clinics of North America. 2016
- Delirium in older persons. Inouye S.K. Delirium in older persons. New England Journal Medicine. 2006
- Marta Moreno J, Marta Moreno E, Pelegrin Valero C, Ramos Paesa C. Abordaje práctico del delirium. Barcelona: Masson; 2004.